

1 薬剤の分類マップ

高血圧・蛋白尿 VEGF経路の阻害	抗VEGF・VEGFR-2抗体など ベバシズマブ ラムシルマブ アフリベルセプト 経口マルチキナーゼ阻害薬 レンパチニブ ソラフェニブ スニチニブ レゴラフェニブ パゾパニブ アキシチニブ カボザンチニブ
静脈血拴塞栓症 深部静脈血拴症・肺塞栓症	免疫調節薬(骨髄腫) レナリドミド ボマリドミド サリドマイド 内分泌療法(乳がん) タモキシフェン トレミフェン その他 アベマシクリブ シスプラチン
VEGF阻害のその他の副作用 出血・穿孔・創傷治癒	出血・消化管穿孔 ベバシズマブ ラムシルマブ 創傷治癒遅延(手術前後) ベバシズマブ 甲状腺機能低下 レンパチニブ スニチニブ
予防・治療に使う薬 降圧・抗血栓	降圧薬 ARB・ACE阻害薬 Ca拮抗薬 抗凝固薬 アビキサパン エドキサパン リバーロキサパン ヘパリン 抗血小板薬(骨髄腫の予防) アスピリン

 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 —▶ 重い

Grade1	Grade2	Grade3
高血圧 収縮期120～139または拡張期80～89mmHg	高血圧 収縮期140～159または拡張期90～99mmHg、治療を要する	高血圧 収縮期160以上または拡張期100以上、2剤以上の治療を要する
蛋白尿 1+(1.0g/日未満)	蛋白尿 2+～3+(1.0～3.5g/日未満)	蛋白尿 3.5g/日以上、4+
保険薬局での対応 家庭血圧の記録を継続、減塩を支援	保険薬局での対応 降圧薬の開始・調整のため処方医へ情報提供	保険薬局での対応 休薬の判断が必要。至急処方医へ連絡

強い頭痛・見え方の異常・意識の変化を伴う血圧上昇は、高血圧緊急症や可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を疑い至急受診

3 副作用の特徴と発現時期

	開始日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● 高血圧(VEGF経路阻害薬)	開始後数日～数週で上昇					
● 静脈血栓塞栓症(レナリドミド)		開始後数か月が多い				
● 蛋白尿			数週～数か月			
● 出血(VEGF阻害薬)	時期を問わず					
● 甲状腺機能低下(TKI)				数か月以降		
● 静脈血栓塞栓症(タモキシフェン)				長期服用中も		
● PRES(まれ)	まれ・時期を問わず					

 重篤・特に注意 その他

押さえておきたいポイント

- VEGF経路阻害薬は高血圧・蛋白尿が高頻度。開始前から家庭血圧を記録し、来局ごとに確認
- 片足の腫れ・急な息切れは血拴症、強い頭痛・見え方の異常はPRESを疑い至急受診
- レナリドミドの血拴予防と、抗凝固薬の出血・相互作用を薬局で確認